

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

ДК 616–092:612.017.1(048.8)

*В.М.Атаманов, Т.П.Демичева, Н.В.Светлакова, Н.С.Казаева,
Е.Н.Марченко, М.Ю.Батуева, О.В.Шанько*

АУТОИММУННЫЕ ПОЛИГЛАНДУЛЯРНЫЕ СИНДРОМЫ

Аутоиммунные полигландулярные синдромы (АПГС) представляют собой поражение аутоиммунным процессом 2 и более периферических желез, которое приводит к их недостаточности. В настоящее время выделяют АПГС 1-го и 2-го типа, оба заболевания генетически детерминированы. АПГС 1-го типа (APECED – Autoimmune polyendocrinopathy–candidiasis–ectodermal–dystrophy, MEDAC – Multiple Endocrine Deficiency Autoimmune Candidas, кандидополиэндокринный синдром) – заболевание с ауто-сомно-рецессивным типом наследования. Для него характерна триада синдромов: слизисто-кожный кандидоз, гипопаратиреоз, первичная хроническая надпочечниковая недостаточность (ХНН). Кроме того, в 30 % случаев возникает алопеция, 26–45 % – первичный гипогонадизм, первичный гипотиреоз в 10 %. Заболевание дебютирует в детском возрасте и первым проявлением является слизисто-кожный кандидоз, с последующим присоединением гипопаратиреоза и развитием в среднем через 2 года – ХНН. АПГС 1 был описан E. Thorpe в 1929 г. Описание данного заболевания встречается редко. В отечественной литературе мы нашли 2 сообщения об АПГС 1 у детей 10 лет. В связи с редкостью встречаемой патологии, трудностью диагностики и лечения данного заболевания нам представляется интересным опу-

бликование 2 клинических наблюдений с АПГС 1-го и 2-го типа. Причем АПГС 1 типа мы наблюдали у 2 сестер, у одной из которых манифестация в 2 года слизисто-кожным кандидозом и гипопаратиреозом, а в возрасте 15 лет – острая надпочечниковая недостаточность с последующим присоединением клиники гипотиреоза, гипогонадизма и алопеции.

Больная Ч.Л., 23 г., госпитализирована с жалобами на слабость, головную боль, снижение зрения, неустойчивость стула. Из анамнеза известно, что девочка родилась от вторых родов и пятой беременности (у матери было 4 выкидыша). Вес при рождении – 3 кг, рост – 49 см. Роды срочные. Выписана из роддома с кандидозом ротовой полости; после профилактической прививки – рецидив кандидоза, а в возрасте 1 года перенесла кандидостафилококковую пневмонию с плевритом, пневмотораксом и кандидозным сепсисом, после переливания СЗП – гепатит В. С 5-летнего возраста появился судорожный синдром, состояние было идентифицировано как эпилепсия и назначена противосудорожная терапия. В 10 и 12 лет пациентка оперирована по поводу катаракты правого и левого глаза. С 15 лет стала замечать снижение массы тела, стойкую гипотонию, бронзовый оттенок кожи, рвоту, диарею. В ноябре 1996 г. впервые была госпитализирована в эндокринологическое

отделение с клиникой острой надпочечниковой недостаточности, имевшей тяжелое течение и устойчивой к терапии глюкокортикоидами и минералокортикоидами. На момент осмотра состояние больной удовлетворительное. Кожные покровы с гиперпигментацией естественных складок, гиперкератоз стоп, локтей. Ногтевые пластинки тусклые, желтоватого цвета, ломкие. Синдром Хвостека слабopоложительный. Оволосение по женскому типу, скудное на лобке и в аксиллярных областях. Больная пониженного питания. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 84 в мин. АД – 105/70 мм рт. ст. Язык суховат, обложен у корня белым налетом. Живот мягкий, абдоминальные боли нечеткой локализации. При параклиническом обследовании: кальций крови – 2,03 ммоль/л (норма 2 – 3), кортизол – 423 нмоль/л (норма 140 – 690), содержание 17 КС в моче – 0,9 мг/сут (норма 3,3 – 12), Са мочи – 14,8 ммоль/л в сутки (норма 2,50-6,25). При исследовании кала на дисбактериоз обнаружена энтеропатогенная эшерихия и большое количество условно – патогенной флоры. На ЭКГ – ритм синусный, 78 в мин, диффузные изменения в миокарде. При ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены диффузные изменения почек, надпочечники не изменены. Окулист описывает афакию, частичную атрофию зрительного нерва. На основании объективного осмотра, данных анамнеза и лабораторно-инструментальных исследований был диагностирован АПГС 1-го типа (генерализованный слизисто-кожный кандидоз, врожденный первичный гипопаратиреоз, ХНН, первичный гипотиреоз, врожденный иммунодефицит). Больной проводилась заместительная терапия глюкокортикоидами (преднизолон 15 мг в сутки), минералокортикоидами (кортинеф 0,2 мг в сутки), L-тироксинам (100 мкг в сутки), препаратами кальция, противогрибковыми препаратами, эубиотиками.

Сестра больной Ч.Л., 18 лет, с 4-летнего возраста состояла на учете у эндокринолога. В 4,5 года появилась деформация ногтей на кистях, изменение слизистой ротовой полости, языка. Была направлена в г. Санкт-Петербург, где установлен диагноз «аутоиммунный полиэндокринный синдром на фоне врожденного иммунодефицита. Гипопаратиреоз, гипотиреоз. ХНН. Кандидоз слизистых, ногтевых пластинок». Ежегодно госпитализировалась для обследования и коррекции проводимой терапии. Больная принимала L-тироксин, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, препараты кальция, периодически – противогрибковые препараты. Из анамнеза жизни известно, что родилась и проживает в г. Перми с родителями, имеет 2 сестер и брата. Наследственность отягощена: АПГС 1-го типа у сестры, сахарный диабет 2-го типа у бабушки. Гинекологический анамнез – месячные с 14 лет, регулярные, цикл 30 дней; половая жизнь с 14 лет. При осмотре: кожные покровы бледные, явления ангулярного стоматита, деформация ногтей на кистях. Пониженного питания. Вес 40 кг, рост 158 см. Оволосение по женскому типу. Щитовидная железа пальпируется в виде небольшого тяжа. Симптомы Хвостека и Труссо отрицательные. Патологии внутренних органов при осмотре не обнаружено. АД – 110/70 мм рт. ст. ЧСС – 72 уд/мин. Общий и биохимический анализы крови не изменены. В моче повышено содержание кальция (13,8 ммоль/л) и снижено содержание фосфора (21,7 ммоль/л в сутки, при норме 25,8-48,4), уровень кортизола крови – 349,7 нмоль/л, в иммунограмме – значительное снижение всех показателей Т-кл. типа. УЗИ щитовидной железы: общий объем – 9,8 см³, диффузные изменения в железе. На ЭКГ: наличие укороченного интервала PQ, удлинение QT (признак гипокальцемии). У больной был диагностирован «аутоиммунный полиэндокринный синдром.

Хроническая надпочечниковая недостаточность. Первичный гипопаратиреоз, Первичный гипотиреоз. Первичное врожденное иммунодефицитное состояние преимущественно Т-кл типа. Генерализованный кандидоз слизистых и кожи». Обе сестры обследованы в микоцентре г. Санкт-Петербурга, где установлена генетическая природа заболевания, причина которого – отец девочек, являющийся носителем патологической Х-хромосомы.

АПГС 2-го типа наиболее распространенный, но наименее изученный вариант АПГС. Впервые в 1926 г. Шмидтом были описаны 2 больных с хроническим тиреоидитом и первичной надпочечниковой недостаточностью. Термин «аутоиммунный полигландулярный синдром» был введен в 1980 г. M. Neufeld, который определил АПС-2 как сочетание ХНН с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) и/или сахарным диабетом при отсутствии гипопаратиреоза и слизисто-кожного кандидоза, тем самым выделив кардинальные различия АПГС 1-го и АПГС 2-го типа. В большинстве случаев АПГС 2-го типа встречается спорадически, однако, описаны и семейные формы, примерно в 8 раз чаще встречается у женщин, манифестирует в возрасте 20-50 лет. Для АПГС 2-го типа характерна ХНН, АИТ, у каждого второго сахарный диабет и витилиго, а в 16 % случаев – первичный гипогонадизм и макроцитарная анемия.

Нами наблюдалась пациентка, 52 г., с АПГС 2-го типа (вариант Шмидта), которая попала в поле зрения эндокринолога в период клиники острой надпочечниковой недостаточности. Из истории заболевания: 4 года назад появились отеки на лице, по поводу чего лечилась у уролога с диагнозом «хронический пиелонефрит». Состояние больной ухудшалось: нарастал отечный синдром, появились симптомы гипотиреоза, на фоне стресса появилась резко выраженная слабость, снижение АД

до 60/40-20 мм рт. ст. В связи с головокружением и обморочным состоянием госпитализирована в реанимационное отделение. У больной верифицирована острая надпочечниковая недостаточность. Из истории жизни известно, что родилась и выросла в г. Перми, от сверстников в развитии не отставала. Образование среднее специальное, в настоящее время работает частным предпринимателем. Менструации с 13 лет, регулярные, через 30 дней, беременностей – 3, родов – 2, медицинский аборт – 1. В 1982 г. – вторые роды, осложнившиеся преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты; патологическим кровотечением с последующей (надвлагалищной) ампутацией матки и гибелью ребенка. В этот же период появилась преходящая полиурия (до 7 л) с полидипсией, в связи с чем пациентка получала адиурекрин, в течение недели данные симптомы регрессировали; повторных эпизодов в последующем не было. Перенесенные заболевания: в детстве – вирусный гепатит, хронический пиелонефрит, синкопальные состояния, расцененные как вертеброгенная недостаточность; ЧМТ, туберкулез, кожно-венерические заболевания отрицает. На момент осмотра отмечается сухость кожных покровов, они холодные на ощупь; гиперпигментация ладонных линий, в местах трения под суставными поверхностями кистей. Лицо отечное, речь замедлена. Оволосение по женскому типу. Щитовидная железа не пальпируется. Левая граница сердца смещена влево. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД=120/80 мм рт.ст. ЧСС – 58 уд/мин. Со стороны органов дыхания и пищеварительной системы без особенностей. Отклонения при параклиническом обследовании: в ОАК – умеренный лимфоцитоз (50 %), в биохимическом анализе крови – гиперлипидемия (β -ЛП до 10,2 г/л), K^{+} –

4,25 ммоль/л, Na^+ - 135 ммоль/л, глюкоза - 4,02 ммоль/л. ЭКГ: брадикардия – 55 в мин, ритм синусовый, выраженные дистрофические изменения в миокарде. При УЗИ органов брюшной полости обнаружены признаки хронического холецистита, умеренная дилатация ЧЛС обеих почек. Р-графия черепа: костные структуры черепа не изменены. В спинке турецкого седла костная киста 8х2 мм. Основная пазуха пневматизирована удовлетворительно. Найдены диффузные изменения по УЗИ щитовидной железы, общий объём железы. – 7,5 см³. Гормональное обследование: кортизол крови – 2,8 нмоль/л (в норме 9-26); ТТГ – 4,94 мкМЕ/мл (в норме 0,4-4,0); св. Т₄ – 0,6 нмоль/л (0,8-1,9); пролактин – 52,3 мкЕд/л (54-900); АТ к ТПО – 233 (до 30) ед. Окулист: глазное дно – ангиопатия сетчатки. Диски зрительных нервов – розовые, очерченные. Артерии умеренно равномерно сужены. Вены полнокровны. Сетчатка прозрачная.

Вышеуказанные данные позволили определить у больной АПГС 2-го типа, синдром Шмидта. АИТ, атрофический вариант, первичный гипотиреоз, хроническую надпочечниковую недостаточность, хронический пиелонефрит (н/фаза), состояние после надвлагалищной ампутации матки (1981 г.).

На фоне проводимой заместительной терапии минералокортикоидами (кортинеф), эутироксом отмечалась положительная динамика: уменьшились сонливость, отеки на лице, исчезла гиперпигментация ладонных линий, АД нормализовалось, но сохранялась сухость кожи. Больной было рекомендовано: заместительная терапия, обследование родственников на предмет выявления аутоиммунных заболеваний и их лечение.

Для ранней диагностики у родственников больных АПГС 2-го типа аутоиммунных заболеваний рекомендуется наблюдение за функцией щитовидной железы, надпочечников, скрининг для выявления сахарного диабета, так как это наиболее часто встречающиеся компоненты АПГС 2-го типа. Скрытые эндокринные заболевания имеются у 1 из 6 родственников больного АПГС 2-го типа. При выявлении генетических и иммунологических маркёров предрасположенности к аутоиммунным заболеваниям их можно обнаруживать на доклинической стадии и начать лечение задолго до клинического проявления заболевания, предотвратить его прогрессирование. Знание закономерностей развития АПГС имеет большое практическое значение, т.к. ранняя диагностика и обследование родственников больных АПГС 1-го и 2-го типов помогает своевременно начать заместительную терапию.

*Пермская государственная
медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера*

Материал поступил в редакцию 20.12.2005